

Exercices du plancher pelvien & rééducation vésicale

Information pour le patient · Traitement de première intention simple et efficace pour les fuites et les urgences **WARWIKI**

Deux des approches les plus efficaces pour mieux contrôler la vessie ne nécessitent ni médicament ni chirurgie : les **exercices du plancher pelvien** (souvent appelés exercices de Kegel) renforcent les muscles qui retiennent l'urine, et la **rééducation vésicale** réapprend à la vessie à patienter plus longtemps entre les mictions. Pratiqués régulièrement, ils aident à réduire les fuites d'effort, les urgences et la pollakiurie — et sont gratuits et sans danger.

Comment ils aident

- Les **exercices du plancher pelvien** renforcent le soutien musculaire sous la vessie et l'urètre, ce qui réduit les fuites lors d'une toux, d'un effort ou d'une activité physique — et permet de mieux maîtriser les urgences.
- La **rééducation vésicale** allonge progressivement le temps entre les passages aux toilettes, calmant une vessie hyperactive et diminuant la pollakiurie.

Trouver les bons muscles

Les muscles du plancher pelvien sont ceux que vous utiliseriez pour **arrêter le jet d'urine** ou retenir un gaz. Contractez-les et soulevez-les vers le haut, **sans** serrer le ventre, les fesses ou les cuisses, et **sans bloquer votre respiration**. (Ne vous entraînez pas en interrompant réellement votre jet — c'est seulement pour les repérer.) Si vous n'arrivez pas à les identifier, un(e)

kinésithérapeute spécialisé(e) en rééducation périnéale peut vous aider, parfois par biofeedback.

COMPRENDRE LES TERMES

Plancher pelvien

L'ensemble des muscles soutenant la vessie, l'intestin et (chez la femme) l'utérus.

Exercices de Kegel

Contractions et relâchements des muscles du plancher pelvien.

Rééducation vésicale

Allongement progressif du temps entre les mictions.

Suppression de l'urgence

Calmer une envie soudaine pour atteindre les toilettes sans fuite.

Biofeedback

Outil qui vous montre si vous contractez les bons muscles.

Kiné périnéale

Thérapeute spécialisé(e) dans ces muscles.

COMBIEN DE TEMPS AVANT DE VOIR DES RÉSULTATS ? Soyez patient(e) — la plupart des personnes constatent une amélioration après environ **6 à 12 semaines** de pratique régulière, et les progrès continuent avec la constance. Comme tout exercice, les bénéfices s'estompent si vous arrêtez — l'objectif est d'en faire une habitude quotidienne durable.

Une routine quotidienne simple

- 1 **Contractez** les muscles du plancher pelvien et maintenez 3 à 5 secondes, puis relâchez complètement pendant le même temps.
- 2 Répétez environ **10 fois** et effectuez **3 séries par jour**. Augmentez progressivement la durée de contraction.
- 3 Ajoutez quelques **contractions rapides et puissantes** à utiliser juste avant de tousser, d'éternuer ou de soulever un objet (la « technique du verrouillage »).
- 4 Relâcher complètement entre les contractions est aussi important que la contraction elle-même.

Rééducation vésicale

- Tenez un court **journal mictionnel** pour observer votre schéma habituel.
- Lorsqu'une urgence survient, **arrêtez-vous, contractez le plancher pelvien, respirez et attendez que l'envie passe** — puis marchez calmement vers les toilettes.
- Prolongez progressivement le temps entre les mictions par paliers de 15 minutes, en visant toutes les 3 à 4 heures.

Bon à savoir

- Vous pouvez faire ces exercices **n'importe où** — personne ne le remarque.
- La régularité prime sur l'intensité ; associez-les à des repères quotidiens (repas, feux rouges).
- En cas de **douleurs pelviennes** ou de plancher pelvien très tendu, l'objectif peut être de **détendre** (et non de renforcer) — demandez conseil à votre équipe soignante.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Du mal à savoir si vous contractez les bons muscles
- Des exercices qui **aggravent la douleur** ou la pression
- Aucun changement après quelques mois

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Les exercices du plancher pelvien et la rééducation vésicale sont des premières étapes sûres, gratuites et reconnues contre les fuites, les urgences et la pollakiurie.
2. Contractez les bons muscles (sans bloquer la respiration), relâchez-les complètement, et réapprenez à la vessie à patienter un peu plus longtemps.
3. Donnez-vous 6 à 12 semaines et persévérez. Si la douleur s'aggrave ou que vous ne trouvez pas les muscles, demandez une rééducation périnéale.